

UZAKTAN SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ KILAVUZU

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), Bakanlık tarafından üretilen veya Bakanlık tarafından tescil edilmek suretiyle uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan güvenli yazılımdır. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları; *“Uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlık veya Bakanlık harici yetkilendirilmiş geliştiriciler tarafından Bakanlığın belirlemiş olduğu asgari standartlara uygun olarak geliştirilir. Geliştirilen uzaktan sağlık bilgi sistemi, Bakanlığın sistemine tescil edilir; tescili yapılmamış uzaktan sağlık bilgi sistemi uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılamaz. Tescilin usûl ve esasları Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüince belirlenerek Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur.”* hükümlerini içermektedir. Bu Kılavuz anılan hükümler doğrultusunda USBS’lerin sahip olması gereken asgari özellikleri tanımlamaktadır.

USBS’ler Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi vb. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) ile entegre çalışan ve entegre olmadan çalışabilecek şekilde iki farklı yöntemle geliştirilebilir.

Yüklenici, USBS’nin Bakanlık tarafından belirlenen veri tanımlarına, iş kurallarına, yayımlanan yazılım sürüm notlarına, sağlık bilişim standartlarına, geliştirmelere ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Genel Nitelikler

1. USBS üzerinde kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlayan ara yüzler olmalıdır.
2. Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlayan ara yüzlere yalnızca yetkili kullanıcılar erişebilmelidir.
3. USBS ara yüzlerine erişim için iki aşamalı kimlik doğrulama (parola haricinde teyit edilmiş iletişim kanalına gönderilen kod ile doğrulama yapılması – Two Factor Authantication örneğin SMS, e-posta doğrulama, offline şifrematik, OTP, vb.) yapılmalıdır.
4. Kullanıcı giriş ekranında hatalı giriş olduğu durumlarda CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi) doğrulaması olmalıdır.
5. Tüm başarılı ve başarısız kimlik doğrulama girişimleri için iz kaydı oluşturulmalıdır.
6. IP ve User (Kullanıcı) bilgisi iz kaydı içinde tutulmalıdır.
7. Kimlik doğrulama (Parola) bilgileri geri dönüşümsüz olarak saklanmalıdır.
8. Türkçe dil desteği olmalıdır.
9. USBS ile taraflar (Hastalar ile sağlık personeli vb.) arasındaki iletişim şifreli olarak (SSL, Blok Zincir teknolojisi, Hashing vb.) gerçekleştirilmelidir.
10. Çift yönlü iletişime imkân veren sesli ve görüntülü görüşme yeteneği bulunmalıdır.
11. Çift yönlü iletişime imkân veren anlık mesajlaşma yeteneği olmalıdır.
12. Hastanın dosya transfer imkanı bulunmalıdır.
13. Hastanın dosya transferinde zararlı içerik barındıran dosyaların engellenmesi için güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.

14. USBS ile sađlık tesisindeki SBYS'ler arasında bir entegrasyon yapılması durumunda bu entegrasyon guvenli iletisim protokolleri kullanılarak gerceklestirilmelidir.
15. USBS ile Bakanlık merkezi veri kayıt sistemi vb. arasında yapılan entegrasyonlar, guvenli iletisim protokolleri kullanılarak gerceklestirilmelidir.
16. Gorusme yapan sađlık personelinin adi, soyadi, unvani ve var ise uzmanlik bilgisi USBS uzerinden goruntulenebilmelidir.
17. Uzaktan sađlık hizmeti verilmesi islemi oncesinde, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu mevzuati, uzaktan sađlık hizmeti sunumuna iliskin sartlar hakkında taraflarin bilgilendirilmesine yonelik ara yuzler bulunmalidir.
18. Uzaktan sađlık hizmeti islemi oncesinde kamera ve mikrofona erisim saglanacagina iliskin taraflar bilgilendirilebilmeli ve onaylari alınabilmelidir.
19. Goruntulu ve sesli gorusme esnasinda taraflar ses ve/veya goruntuyu kapatma imkanina sahip olmalidir.
20. Taraflardan her ikisi de gorusmeyi sonlandirma imkanina sahip olmalidir.
21. USBS ara yuzlerinden yapılan tum islemler (log on, log, off, yeni kayıt, kayıt guncelleme, kayıt silme, acik riza alma vb.) icin asgari olarak olay aciklamasi, olay kaynagi, olay zamanı, kullanıcı/sistem bilgisi, kaynak adresleri, hedef adresleri ve islem detayları bilgilerini icerecek sekilde iz kaydı tutulmalidir.
22. USBS'de hasta demografik verilerinin listelendiđi ara yuz bulunmalidir.
23. USBS, T.C. Kimlik Numarası dogrulama algoritması kullanmalidir.
24. USBS'nin CKYS Doktor Bilgi Bankası entegrasyonu olmalidir.

25. e-Nabız Sistemi üzerinden hastanın geçmiş raporları, reçeteleri, tıbbi görüntüleri, tahlil sonuçları vb. bilgi ve belgeleri görüntülenebilmelidir.
26. Uygulama verileri, kurumun kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yurt içi bulut ortamlarında saklanabilmelidir.
27. USBS içinde yer alan anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme yeteneği için kullanılan sunucular, yurt içinde ve kurum kontrolünde olmalıdır.
28. USBS'nin sunuculara kurulumu USBS üreticisinin sorumluluğundadır.
29. USBS'den diğer SBYS'lere yapılacak entegrasyon için gerekli web servis veya yöntemlere ilişkin dokümantasyon USBS üreticisi tarafından sağlanmalıdır.
30. USBS firması sistemin güvenlik testlerinin düzenli olarak yapıldığını ve siber olaylara karşı gerekli önlemlerin alındığını yazılı olarak taahhüt etmelidir.
31. USBS üzerinden ikiden fazla kişi aynı anda görüşme (ör. tercümanlık hizmetleri, konsültasyon, sağlık kurulu süreçleri vb. için gerekmesi hallerinde) yapabilmelidir.

USBS, uzaktan sağlık hizmeti esnasında görüntü ve/veya ses kaydı yapabiliyorsa aşağıdaki özellikler USBS'de olmalıdır.

1. Sağlık hizmeti verilmesi öncesinde ses ve/veya görüntü kaydı almak için tarafların bilgilendirilmesine ve açık rızasının alınmasına yönelik mevzuata uygun ara yüzler olmalıdır.
2. Ses ve/veya görüntü kaydı almak için tarafların onayı alınabilmelidir.
3. Taraflar onay vermeden ses ve/veya görüntü kaydının alınması engellenmelidir.
4. USBS üzerinden alınan ses ve/veya görüntü dosyaları şifreli olarak saklanmalıdır.

5. USBS üzerinden alınan ses ve görüntü kayıtlarına yetkisiz kişilerin erişmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
6. USBS üzerinden alınan ses ve görüntü kayıtları, mevzuatta belirtilen sürenin dolması sonrasında otomatik bir şekilde kalıcı olarak silinmelidir.
7. USBS veri tabanında ses ve görüntü kaydı için hastadan açık rıza alındığına dair kayıt bulunmalıdır.
8. Hastaya ait tanı kodları ICD-10 kullanılarak girilebilmeli ve tanı kodlaması yapılmamış hastaların işlemi tamamlanamamalıdır.
9. Detaylı tanı giriş ekranı oluşturulabilmelidir. Aynı ekran üzerinde ICD-10 listesinin kısırlımlı bir şekilde detaya inebilmesi sağlanabilmelidir. En çok girilen tanıları, sık kullanılan hastalıklar branş bazında ve istenilen bazda listelenebilmelidir.
10. Hekimlerin, detaylı not yazabileceği, notlarına tarih bazında erişebileceği hekim notu arayüzü ile hastaların hekimlerine not yazabileceği bir arayüz olmalıdır.
11. USBS’de rol tabanlı yetkilendirme olmalı ve kullanıcı hesaplarının yönetildiği arayüzlere yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesi sağlanmalıdır.
12. Hasta eğer hekim tarafından hastaneye yönlendirilmişse veya sevk edilmişse hangi hekim tarafından yönlendirildiği/sevk edildiği bilgisi USBS’ye kaydedilebilmelidir.

USBS, HBYS / MBYS / AHBS ile entegre olmadan çalışabiliyor ise aşağıdaki özellikler USBS’de olmalıdır. USBS, bu entegrasyonlar olmadan çalışmıyor ise HBYS/MBYS/AHBS yazılımları ile entegrasyon yeteneği bulunmalıdır.

1. USBS üzerinde randevu alınacak poliklinik veya hekim bilgilerinin listesi olmalıdır.
2. USBS üzerinden randevu alınabilmelidir.

3. Hekim USBS üzerinden başka bir Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine bağlanmadan e-reçete ve e-rapor düzenleyebilmelidir.
4. Hekim muayene bulgularını USBS'ye kayıt edebilmelidir.
5. Hekim USBS üzerinden hastaya ilişkin özel notlarını kaydedebilmelidir.
6. USBS ile e-Nabız sistemi arasında veri gönderimi entegrasyonu olmalıdır.